

Chalmers: 자가면역 구강 검진 단서 — 핵심 요약

1. 핵심 개념

- 구강 검진 = 자가면역 질환의 중요한 조기 단서 제공
- 검진 집중 부위: 혀, 구강 점막, 타액
- 감별 진단 3대 고려 사항: 셀리악병 / 치과 수복 재료 반응 / 구강 위생 제품 반응

2. 자가면역 시사 구강 소견

혀 소견:

위축성 설염, 측면 가리비 모양, 등면 균열, 지도상 혀

구강 점막 소견:

구강 궤양, 적색/백색 반점 → 반드시 조직검사 의뢰

주의: 양측성 구강 편평태선 = 자가면역(일부 암전 병변)

타액 검사:

이하선관 건조 후 타액 분비 즉시 없으면 → 타액 감소 의심

3. 임상 적용 포인트

- 야간 마우스가드: BPA·BPS·프탈레이트·글루텐 함유 → 생체적합 재료로 교체 시 타액 기능 회복
- 자가면역 환자 근관 치료: 뼈 치유 어려움 → 발치+임플란트/브릿지 고려
- 혼합 금속 치과 수복물: 자가면역 트리거 가능 → 재료 변경 검토

4. 핵심 임상 진주

- 치과의사가 자가면역 질환의 첫 번째 발견자가 될 수 있음
- 구강 증상 → 전신 상태(셀리악병, 자가면역) 연결 고리 탐색
- 타액 분비 감소: 약물 외 셀리악병·수복 재료 알레르기 조기 확인하면 회복 가능